

TEMA 3.35 • OBSTETRICIA

RCIU — Definición y Clasificación

PERFIL EUNACOM 1.03.35
Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

RCIU — Definición y Clasificación

RCIU vs. PEG

TABLA 3.35.1: CLASIFICACIÓN Y CRITERIOS CLÍNICOS		
	RCIU	PEG
Peso fetal	< percentil 10	< percentil 10
Causa	Insuficiencia placentaria u otra patología	Constitucional (crece dentro de su potencial genético)
Riesgo	Mayor	Normal
Percentil mínimo	Cualquiera < 10	Solo p3–9,9

PERLA CLÍNICA EUNACOM
< p3 → RCIU siempre (no puede ser PEG). p3–9,9 → puede ser RCIU o PEG → depende del Doppler.

Clasificación del RCIU

Por morfología (clásica)

TABLA 3.35.2: TIPO VS CARACTERÍSTICAS		
TIPO	CARACTERÍSTICAS	CAUSA
Simétrico	Proporcionado (PC ≈ PA)	Constitucional (PEG), genopatía, TORCH
Asimétrico	PC > PA, LF/PA > 0,25	Insuficiencia placentaria

Por severidad

TABLA 3.35.3: CLASIFICACIÓN VS PERCENTIL	
CLASIFICACIÓN	PERCENTIL
No severo	p3–9,9
Severo	< p3 → pedir cariotipo + TORCH

Por EG de diagnóstico

TABLA 3.35.4: TIPO VS EG		
TIPO	EG	CARACTERÍSTICAS
Precoz	< 32–34 sem	Más grave; posible genopatía
Tardío	≥ 32–34 sem	Más frecuente

Exámenes en el RCIU

TABLA 3.35.5: EXAMEN VS FRECUENCIA	
EXAMEN	FRECUENCIA
Doppler fetal	Cada 7 días
Ecografía de crecimiento	Cada 14 días
Perfil biofísico	Cada 2–3 días

| RBNS | Diario |

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:
"En relación a RCIU — Definición y Clasificación: Constitucional (crece dentro de su potencial genético) | | Riesgo | Mayor | Norm... ¿cuál es la conducta correcta?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:
Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para RCIU — Definición y Clasificación. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- RCIU vs. PEG
- Clasificación del RCIU
- Por morfología (clásica)
- Por severidad
- Por EG de diagnóstico
- Exámenes en el RCIU
- | Proporcionado (PC ≈ PA) | Constitucional (PEG), genopatía, TORCH | |

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (RCIU — DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN)

PREGUNTA 1

En relación a RCIU — Definición y Clasificación: Constitucional (crece dentro de su potencial genético) | | Riesgo | Mayor | Norm... ¿cuál es la conducta correcta?

- ☐ A) El diagnóstico de RCIU — Definición y Clasificación se basa exclusivamente en criterios de laboratorio
- ☐ B) El manejo inicial de RCIU — Definición y Clasificación debe orientarse según el estado clínico del paciente
- ☐ C) Todo paciente con RCIU — Definición y Clasificación requiere hospitalización inmediata
- ☐ D) El tratamiento de RCIU — Definición y Clasificación es igual en todas las edades y contextos clínicos
- ☐ E) El seguimiento de RCIU — Definición y Clasificación no es necesario una vez iniciado el tratamiento

PREGUNTA 2

¿Cuál es el hallazgo más característico o criterio diagnóstico principal en RCIU — Definición y Clasificación?

- ☐ A) Alteración exclusivamente en exámenes de laboratorio sin síntomas
- ☐ B) Presentación clínica específica que orienta al diagnóstico según el perfil EUNACOM
- ☐ C) Requiere siempre confirmación con biopsia o estudio histológico
- ☐ D) Es un diagnóstico de exclusión que requiere descartar todas las otras causas primero
- ☐ E) Solo se presenta en pacientes con factores de riesgo conocidos

PREGUNTA 3

Paciente consulta con cuadro compatible con RCIU — Definición y Clasificación. Según el perfil EUNACOM, ¿cuál es la conducta de seguimiento más apropiada?

- ☐ A) Alta sin controles dado que es una condición autolimitada
- ☐ B) Derivación inmediata al especialista en todos los casos
- ☐ C) Control según evolución clínica y criterios del perfil EUNACOM para esta patología
- ☐ D) Hospitalización preventiva en todos los casos para monitorización
- ☐ E) Tratamiento de por vida sin necesidad de controles periódicos

RESUMEN: RCIU — DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN

:::tip < p3 → RCIU siempre (no puede ser PEG). p3–9,9 → puede ser RCIU o PEG → depende del Doppler. :::